Autos: 0800953-93.2020.8.12.0009
Ação: Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor:Edmilson Candido Dias
Requerido e Réu: Município de Costa Rica/ms e outros

Vistos, para sentença.

I. Relatório.

Edmilson Cândido Dias ajuizou a presente "ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência" em face de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Costa Rica, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta na petição inicial que a parte autora foi diagnosticada com isquêmica crônica do coração (CID I25.9), distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias (CID E78), hipertensão essencial primária (CID I10), aterosclerose (CID I70) e outras doenças cardiovasculares periféricas (CID I73).

Para o tratamento, a médica especialista receitou os medicamentos *blitinta* de 90 mg e *diovan* de 360 mg + 12,5 mg. Os fármacos estão registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Postulou pela concessão de tutela provisória de natureza antecipada para obrigar a parte ré fornecer o medicamento, conforme receita médica, indeferido às p. 47-9.

No mérito, requereu a procedência do pedido para determinar que a parte ré forneça os medicamentos na forma constante da prescrição médica.

Fez os pedidos de estilo e juntou documentos (p. 14-29).

Parecer do NAT foi contrário ao pedido (p. 32-46).

A parte ré apresentou contestação.

O Município de Costa Rica sustentou que os fármacos pretendidos pela parte autora não estão disponíveis na farmácia básica municipal, não possuem genérico para substituição e nem constam na lista de medicamentos CEAF, sendo de rigor a improcedência.

No mais, fez o pleitos de praxe.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

O Estado de Mato Grosso do Sul arguiu, preliminarmente, incompetência do juízo estadual.

No mérito, ressaltou a obrigação de fornecimento de medicação pelo ente público somente pode ser determinada se comprovada a presença cumulativa das condicionantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106.

A parte autora não preencheu os requisitos porque não houve o esgotamento do tratamento disponível, além de não haver fundamentação sobre a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Ademais, pretende fazer uso *off label* (fora da bula) dos medicamentos.

Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, no caso de procedência: a) a apresentação obrigatória da receita médica atualizada para retirada do medicamento e autorizado o fornecimento com base no princípio ativo; b) não condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública; c) o direcionamento da obrigação à União e, no caso de execução forçada contra a parte ré, a garantia do direito ao ressarcimento; d) que não seja fixada multa diária se determinada a execução forçada da obrigação; e e) seja observado o PMVG se houver bloqueio de valores.

Formulou os pedidos de estilo.

Houve impugnação (p. 143-69).

Contra a decisão de indeferiu a liminar, a parte autora interpôs recurso, ao qual foi dado provimento (p. 189-216).

Intimadas para indicar as provas que pretendem produzir, as partes pugnaram pelo julgamento do processo no estado em que se encontra (p. 176, 178 e 179).

Após prestações de contas (p. 258-9 e 267-8) e concordância do Estado de Mato Grosso do Sul (p. 275), houve determinação de arquivamento (p. 280).

O Município de Costa Rica depositou R$ 391,23 (trezentos e noventa e um reais e vinte e três centavos) na subconta (p. 283-4) para aquisição do medicamento *diovan*.

A parte autora pugnou pela expedição de alvará (p. 286-8).

É o relatório necessário.

Decido.

II. Fundamentação.

a) Da incompetência do Juízo Estadual.

Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada no Incidente de Assunção de Competência nº 14, determinou que a Justiça Estadual se abstenha de proferir decisões declinação de competência em ações que envolvem fornecimento de medicamentos pelo poder público[1].

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 1.234, sedimentou tese para fixação da competência.

> I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. [...]

Conforme parecer do NAT/JUS, observo que o valor máximo dos medicamentos é R$ 474,72 (quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), de modo que o tratamento anual resulta em quantia inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos (item X – p. 45), não havendo falar em incompetência da justiça comum.

Rejeito a preliminar.

b) Do mérito.

O feito está em ordem. Não há preliminares pendentes ou nulidades a sanar.

O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que não vislumbro a necessidade de produção de outras provas em audiência, estando suficientemente instruído para solução da causa.

[1] Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.

Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

A parte autora pretende a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Costa Rica no fornecimento dos medicamentos *blitinta* de 90 mg e *diovan* de 360 mg + 12,5 mg para o tratamento de isquêmica crônica do coração (CID I25.9), distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias (CID E78), hipertensão essencial primária (CID I10), aterosclerose (CID I70) e outras doenças cardiovasculares periféricas (CID I73).

Inicialmente, aponto que a Constituição Federal de 1988 erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental, estabelecendo em seu art. 196 ser um direito a todos, garantido pelo Estado, ao qual compete o desenvolvimento de políticas que visem à promoção da saúde, redução do risco de doenças e, caso esta já se tenha consolidado, ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para proteção e recuperação da saúde.

A judicialização das políticas públicas de saúde vem atingindo números elevados de ações e de custos, especialmente em função da prescrição de medicamentos não fornecidos pelo sistema. O SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, é compelido à prestação de serviços de saúde, sob os princípios da universalidade e integralidade.

O art. 2º e parágrafo 1º da Lei nº 8.080/90 dispõe o seguinte:

> Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
>
> § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Em relação à obrigação do Estado de fornecer medicamento *off label*, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 106, fixou tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento[2].

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral, acrescentou requisitos outros para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS:

[2] REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018 (Info 625)

Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

> 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
>
> 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
>
> 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024.

Ao seu lado, o item IV da tese fixada no Tema 1234 trata da análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS, sendo complementar ao Tema 6.

> 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

> Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.
>
> 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
>
> 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
>
> 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
>
> 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. STF - RE: 1366243 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024

Além disso, foi editada a súmula vinculante 60, estabelecendo que o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Dessa forma, o Tema Repetitivo 106 do STJ está superado (*overruling*) pelas teses fixadas nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, em especial porque o sistema brasileiro de precedentes, consolidado nos artigos 926 e 927 do CPC, impõe a aplicação imediata das teses definidas pelo STF, independentemente do trânsito em julgado, como método de tutela da segurança jurídica e igualdade, salvo modulação de efeitos[3].

No caso em apreço, o laudo médico juntado às p. 17-20 dos autos comprovam o diagnóstico da parte autora e os medicamentos destinados ao tratamento da moléstia.

[3] TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10332066820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

Entretanto, a comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da doença, não se realizou.

O Parecer Técnico nº 4080/2020 do Núcleo de Apoio Técnico opiniou desfavoravelmente ao fornecimento porque não padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

> **XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.**
>
> Considerando que o paciente está sendo atendido por médico particular;
>
> Considerando que Valsartana + Hidroclorotiazida e Ticagrelor não estão padronizados na RENAME;
>
> Considerando que a SBC recomenda o uso de antiagregante plaquetário (clopidogrel, ticagrelor) por até um ano após a revascularização;
>
> Considerando a recomendação da CONITEC pela não incorporação do Ticagrelor;
>
> Considerando as evidências científicas indicadas no item III, principalmente a revisão sistemática indicando "O uso do ticagrelor como parte da terapia antitrombótica dupla ou tripla está associado a taxas significativamente mais altas de complicações hemorrágicas clinicamente relevantes em comparação com o clopidogrel. Entre os pacientes tratados com terapia tripla, o uso de ticagrelor pode aumentar os eventos cardíacos tromboembólicos e isquêmicos";
>
> Considerando que RENAME 2020 tem padronizado no CBAF medicamentos inibidores ECA/AT1 (Captopril, Enalapril, Losartana), bloqueadores de cálcio (Anlodipino, Nifedipino, Verapamil), betabloqueadores (Atenolol, Carvedilol, Metoprolol, Propranolol), diuréticos (Espironolactona, Furosemida, Hidroclorotiazida), antiagregante plaquetário (Ácido Acetilsalicílico), anticoagulante (Varfarina), corticoide tópico (Dexametasona), antiulcerosos (Omeprazol, Ranitidina), estatina (Sinvastatina);
>
> Considerando o PCDT da Dislipidemia para a Prevenção de Eventos Cardiovasculares e Pancreatite, Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 8 de 30/06/2019, que oferece Atorvastatina, Fluvastatina, Lovastatina, Pravastatina, Sinvastatina, Bezafibrato, Ciprofibrato, Etofibrato, Fenofibrato, Genfibrozila, Ácido Nicotínico, sendo que o paciente não está cadastrado e as informações apresentadas não atendem os critérios de inclusão;
>
> Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao pedido de Valsartana + Hidroclorotiazida e Ticagrelor.

O Parecer Técnico consignou a existência medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde destinados ao tratamento das doenças que acometem a parte autora:

> **IX - Sugerir medicamentos ou tratamentos similares ao requerido, preferencialmente existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) obrigatoriamente registrados na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de comprovada e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de uso e comparação de custo orçamentário;**
>
> A RENAME 2020 tem padronizado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos inibidores ECA/AT1 (Captopril, Enalapril, Losartana), bloqueadores de cálcio (Anlodipino, Nifedipino, Verapamil), betabloqueadores (Atenolol, Carvedilol, Metoprolol, Propranolol), diuréticos (Espironolactona, Furosemida, Hidroclorotiazida), antiagregante plaquetário (Ácido Acetilsalicílico), anticoagulante (Varfarina), corticoide tópico (Dexametasona), antiulcerosos (Omeprazol, Ranitidina), estatina (Sinvastatina).
>
> O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Dislipidemia para a Prevenção de Eventos Cardiovasculares e Pancreatite, Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 8 de 30/06/2019, oferece Atorvastatina, Fluvastatina, Lovastatina, Pravastatina, Sinvastatina, Bezafibrato, Ciprofibrato, Etofibrato, Fenofibrato, Genfibrozila, Ácido Nicotínico aos pacientes cadastrados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

Entre os medicamentos indicados, a parte autora utilizou losaratana, hidroclorotiazida, AAS e apresolina (p. 40), não sendo respondido o motivo de outros fármacos não terem sido indicados (item 6.3 – p. 18)

Com isso, além de os medicamentos não apresentarem comprovação científica de eficácia para combater as doenças que acometem a parte autora, não há como concluir pelo esgotamento do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para seu tratamento e a verificação da ineficiência dos fármacos disponíveis pelo SUS.

Desse modo, não se configura a hipótese de disponibilização de tratamento individualizado, conforme Tema 6 da Repercussão Geral, decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito, transcrevo:

> APELAÇÃO CÍVEL – RETORNO VICE-PRESIDÊNCIA- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – LEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DOS 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ – EXCLUSÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer movida em face do Estado de Mato Grosso do Sul, visando ao fornecimento do medicamento Belimumabe, e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Inicialmente, foi determinada a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, em nova reanálise, verificou-se a aplicabilidade do Tema 1.234 do STF, modulando os efeitos quanto à fixação de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O STF, ao julgar o Tema 1.234 da repercussão geral, estabeleceu que a competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, depende do valor do tratamento anual, sendo da Justiça Federal apenas se superior a 210 salários mínimos. No caso, aplicando-se a modulação dos efeitos decidida pelo STF, a competência permanece na Justiça Estadual. 6. No mérito, o STJ, ao fixar o Tema 106 em sede de recurso repetitivo, determinou que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS; (ii) demonstração da incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. 7. No presente caso, o laudo médico apresentado pela parte autora é genérico, sem comprovação robusta da imprescindibilidade do fármaco pleiteado e do esgotamento das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS. Além disso, o parecer técnico do NAT se manifestou desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento. 8. Diante da ausência dos requisitos necessários, não há direito subjetivo da parte autora à obtenção do medicamento pleiteado, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. As demandas que envolvem fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, devem observar os critérios fixados pelo STF no Tema 1.234 quanto à competência, sendo da Justiça Estadual os processos ajuizados antes da publicação do acórdão que modulou seus efeitos. A

Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

> concessão de medicamentos não padronizados exige o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, sendo imprescindível a comprovação de necessidade do fármaco, ineficácia das alternativas do SUS e incapacidade financeira do paciente. Não preenchidos tais requisitos, impõe-se a improcedência do pedido, ante a ausência de probabilidade do direito. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, Tema 1.234, RE 1.165.959/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves. TJMS. Apelação Cível n. 0824044-08.2021.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 25/02/2025, p: 26/02/2025.

Com efeito, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido[4].

Por fim, verifico que há depósito nos autos (p. 283-4) realizado pelo Município de Costa Rica para fins de cumprimento da decisão de tutela provisória de natureza antecipada, fazendo jus a parte ré o levantamento da quantia, nos termos do parágrafo único do art. 302 do CPC[5].

III. Dispositivo.

Ante o exposto, sentencio o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo improcedente o pedido formulado por Edmilson Cândido Dias em desfavor de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Costa Rica.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais na proporção e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, à luz do art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

Suspendo, todavia, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, eis que beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Regovo a decisão de concedeu a tutela de urgência.

Expeça-se alvará do valor depositado (p. 283-4) em benefício do Município de Costa Rica.

Aforados embargos de declaração, conclusos na fila correspondente.

Interposto(s) recurso(s) de apelação, intime-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, consoante artigo 1.010, § 1º, do CPC.

---

[4] Enunciado nº 14 da I Jornada de Direito da Saúde.

[5] TJMG - Agravo de Instrumento: 28086162020248130000, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 14/11/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2024; TJMS - Agravo de Instrumento: 14195932020238120000 Dourados, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/01/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024.

Endereço: Rua José Pereira da Silva, 405, (67) 3247-1013, Jardim Santos Dummont - CEP 79550-000,
Fone: (67) 3247-1389, Costa Rica-MS - E-mail: csr-2v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.

Manejado recurso de apelação na forma adesiva, intime-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, na forma do artigo 1.010, § 2º, do CPC.

Observe-se eventual prazo em dobro, nos termos dos artigos 180, 183 e 186 do CPC.

Na sequência, independentemente de juízo de admissibilidade, encaminhe-se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul para apreciação do(s) recurso(s).

Transitada em julgada, arquive-se com as devidas anotações no sistema.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Costa Rica-MS, data da assinatura digital.

Atílio César de Oliveira Júnior
Juiz de Direito em Subs. Legal
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 22/07/2025 às 14:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800953-93.2020.8.12.0009 e código swHYsDGQ.